



Escalas PAINAD e FLACC: Avaliação da Dor em Pessoas com Comunicação Verbal Comprometida



Imagem: Designed by Magnific

Desvendando a Dor Silenciosa: Avaliação em Pessoas com Comunicação Verbal Limitada na APS

A fim de dar continuidade à jornada pelo universo do manejo da dor, faz-se necessário abordar um tema que exige sensibilidade e um olhar diferenciado: **a avaliação da dor em pessoas que não conseguem se expressar verbalmente.**



**Por que esse
tema é tão
importante?**

Imagine a seguinte situação: um paciente chega à unidade de saúde com sinais de desconforto, mas não consegue te dizer o que está sentindo. Como você agiria?

A avaliação da dor em pessoas com comunicação verbal limitada (PCVL) é um desafio constante na Atenção Primária à Saúde (APS). **Identificar e manejar a dor de forma adequada faz toda a diferença na qualidade de vida desses indivíduos e na efetividade do cuidado.** Afinal, a dor não expressada não significa ausência de dor!

(Herr *et al.*, 2011)



Quem são as pessoas com comunicação verbal limitada?

Na prática clínica, alguns grupos se destacam.

Bebês e crianças pequenas:

ainda não dominam a linguagem oral para descrever suas sensações.



Sinais de alerta:

choro persistente, alterações no sono e no apetite, expressões faciais de desconforto, agitação ou irritabilidade.

Pessoas com deficiência intelectual:

podem ter dificuldade para compreender e comunicar suas experiências dolorosas.



Sinais de alerta:

mudanças repentinas de comportamento, irritabilidade, agressividade, retraimento social, autolesão.

Idosos com demência:

perdem progressivamente a capacidade de relatar sintomas de forma clara e objetiva.



Sinais de alerta:

agitação, isolamento social, gemidos, alterações no padrão de sono, recusa alimentar, expressões faciais de dor.

Pessoas com deficiência auditiva severa (sem acesso à comunicação apropriada):



enfrentam barreiras na comunicação devido à falta de domínio da língua de sinais, leitura labial ou acesso a intérpretes.

Sinais de alerta: expressões faciais de dor, agitação, irritabilidade, isolamento social.

Soluções: ferramentas visuais, uso de escrita quando apropriado, escalas pictóricas, presença de intérprete de Libras (se possível).

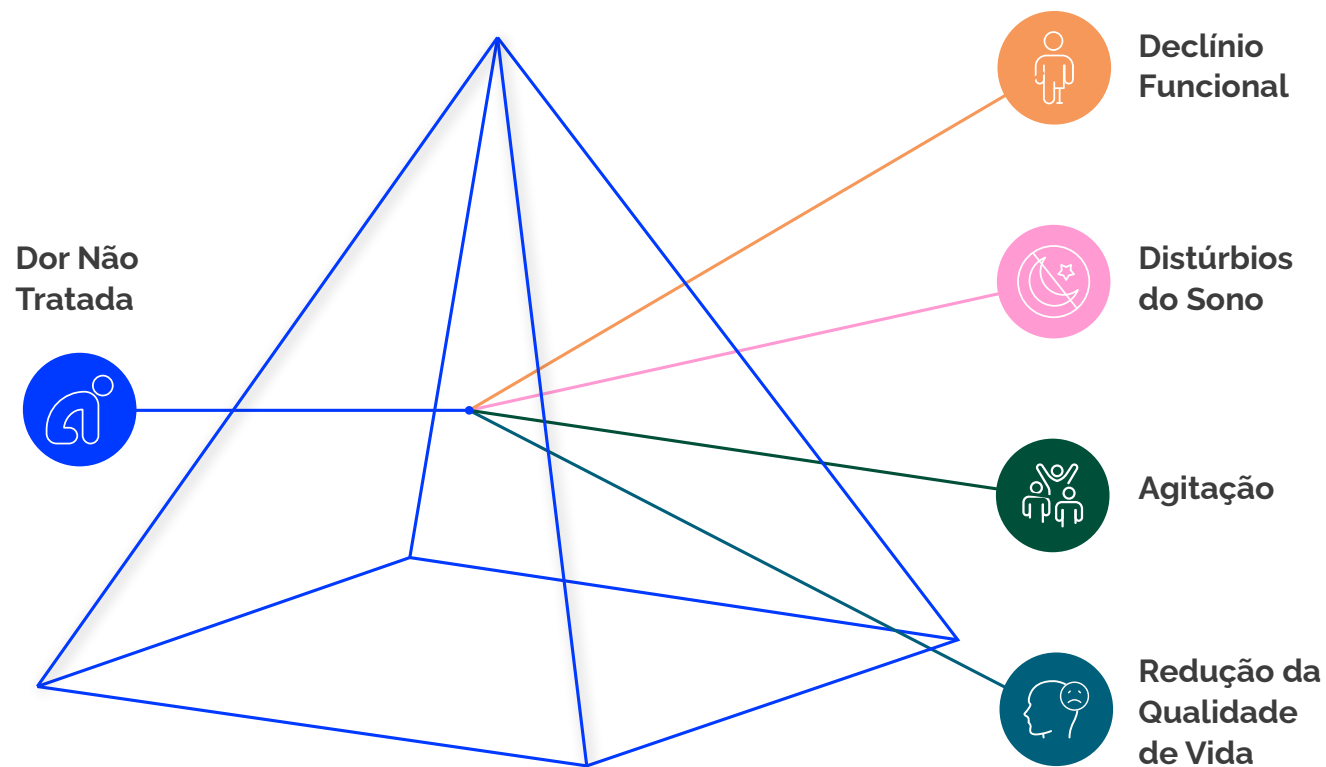


Como podemos "ouvir" a dor que não é dita?

A avaliação da dor em PCVL exige um **olhar atento, sensibilidade e o uso de ferramentas específicas.** A avaliação da dor nesses casos vai além da pergunta direta ao paciente!



Explorando o Impacto da Dor Não Tratada



A avaliação da dor em pessoas com comunicação verbal comprometida representa um desafio significativo na prática clínica.

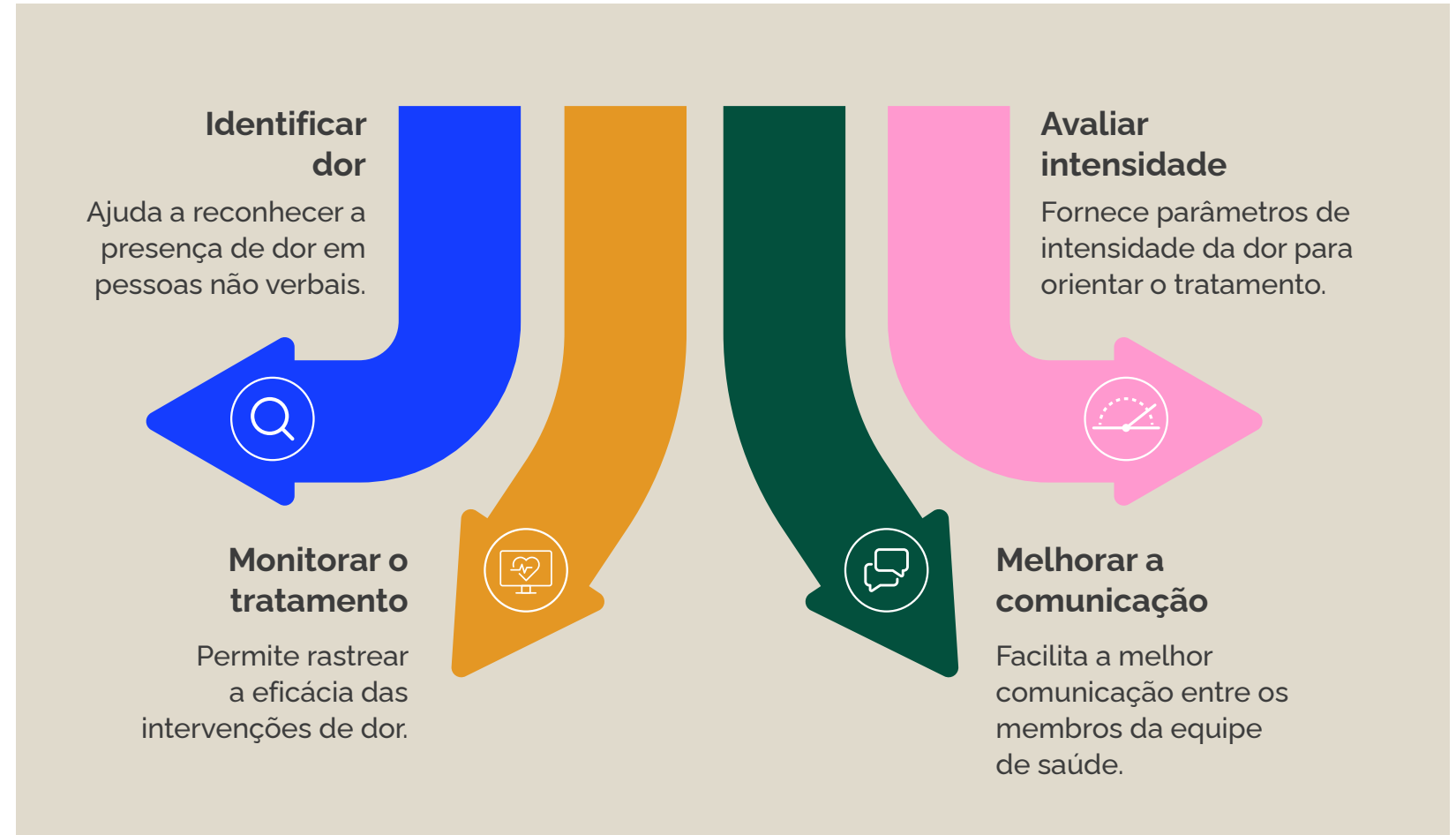
Pessoas com demência avançada, crianças pequenas ou indivíduos não verbais frequentemente não conseguem expressar dor, tornando essencial o uso de ferramentas objetivas e validadas.

As escalas comportamentais PAINAD e FLACC foram desenvolvidas para fornecer avaliações sistemáticas e objetivas da dor nestes grupos específicos de pessoas.



Qual é o objetivo do uso de escalas de dor comportamentais?

O uso destas escalas promove o cuidado centrado na pessoa, permitindo que profissionais de saúde **identifiquem e tratem adequadamente a dor, mesmo quando o paciente não consegue verbalizá-la.**





Ferramentas que podem ajudar na APS

Escala *PAINAD* ***(Pain Assessment in Advanced Dementia)***

Especialmente útil para pessoas com demência avançada.

Observa parâmetros como respiração, expressão facial, linguagem verbal, postura corporal e consolabilidade.

Auxilia na diferenciação entre agitação causada pela dor e outros fatores (Warden; Hurley; Volicer, 2003).

Escala *FLACC* ***(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)***

Ideal para bebês, crianças pequenas e pessoas com limitações na comunicação.

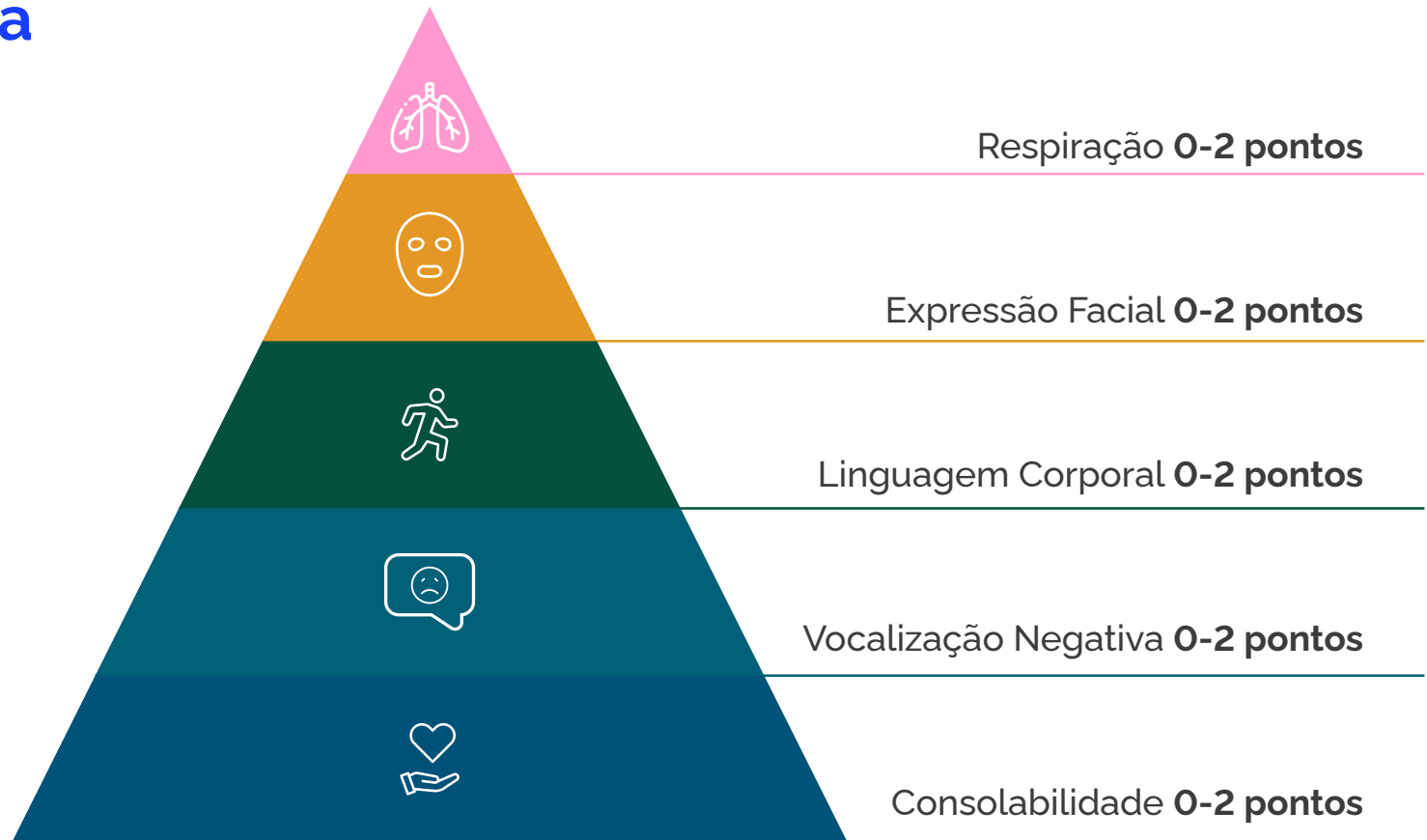
Avalia cinco itens: *Face* (expressão facial), *Legs* (pernas), *Activity* (atividade), *Cry* (choro) e *Consolability* (capacidade de ser consolado). Cada item recebe uma pontuação de 0 a 2, permitindo estimar a intensidade da dor (Malviya *et al.*, 2006).



Escala PAINAD: Avaliação da Dor em Demência Avançada

Desenvolvida por Warden, Hurley e Volicer em 2003, a escala PAINAD foi criada especificamente para pessoas com demência avançada. A aplicação envolve a observação do paciente por 5 minutos durante atividades rotineiras ou em repouso.

A pontuação total varia de 0 a 10, com valores mais altos indicando maior intensidade de dor. Essa escala é recomendada pela *American Geriatrics Society* (AGS) e possui boa validade de construto e confiabilidade interobservador.





Escala FLACC

Avaliação da Dor em Crianças

Desenvolvida por Merkel *et al.* em 1997, a escala FLACC foi criada para avaliar a dor pós-operatória em crianças pequenas (2 meses a 7 anos). A aplicação envolve a observação da criança por 1 a 5 minutos, pontuando cada categoria de 0 a 2.

A pontuação total igualmente varia de 0 a 10, sendo recomendada pela *American Academy of Pediatrics* (AAP) para avaliação da dor em crianças que não conseguem se autorreportar.





Embasamento Científico das Escalas

Escala	Estudo Principal	Resultados	Recomendação
PAINAD	Warden; Hurley e Volicer (2003)	Boa validade de construto e confiabilidade interobservador	<i>American Geriatrics Society</i>
FLACC	Merkel <i>et al.</i> (1997)	Boa validade de construto e sensibilidade a mudanças após analgesia	<i>American Academy of Pediatrics</i>

Ambas as escalas demonstraram ser sensíveis a mudanças na intensidade da dor após intervenções analgésicas, o que confirma sua utilidade clínica. Os estudos de validação comprovaram que essas ferramentas são confiáveis para avaliar a dor em suas respectivas populações-alvo.

As recomendações de sociedades médicas respeitadas reforçam a importância destas escalas na prática clínica baseada em evidências.



Comparação entre PAINAD e FLACC

Embora compartilhem o mesmo objetivo de avaliar a dor em pessoas com comunicação verbal comprometida, cada escala foi desenvolvida considerando as características específicas de sua população-alvo.

A escolha entre PAINAD e FLACC deve ser baseada no perfil do paciente, sendo a primeira indicada para pessoas com demência e a segunda para crianças pequenas.

Semelhanças	Diferenças
Baseadas na observação comportamental;	PAINAD: é específica para demência avançada;
Pontuação total de 0 a 10 pontos;	FLACC: é específica para crianças pequenas;
Aplicação simples e rápida;	São categorias comportamentais distintas;
Boa validade e confiabilidade;	PAINAD: avalia a respiração;
Avaliam a consolabilidade.	FLACC: avalia o choro.



Ferramentas que podem ajudar na APS

Escala Visual Analógica (EVA) e de Faces

São recursos valiosos para pessoas com deficiência auditiva, crianças maiores e adultos com dificuldade na linguagem oral, mas com boa compreensão visual.

Consiste em uma linha ou sequência de faces que representam diferentes intensidades de dor. Permite ao paciente indicar o nível de dor que está sentindo.

Observação do Comportamento

Mudanças no comportamento, como isolamento, recusa alimentar e irritabilidade podem ser sinais indiretos de dor.

Acompanhar o cotidiano do paciente e conversar com familiares e cuidadores pode fornecer informações valiosas.



Boas Práticas na Aplicação das Escalas

Ambiente Adequado



Realizar a observação em local tranquilo e familiar para o paciente, minimizando estímulos que possam interferir na avaliação.

Observação Criteriosa



Observar o paciente durante atividades de rotina ou em repouso, utilizando critérios claros e objetivos para pontuar cada categoria.

Envolvimento Familiar



Incluir familiares e cuidadores no processo de avaliação, considerando seu conhecimento sobre o comportamento habitual do paciente.

Documentação Completa



Registrar todos os achados e avaliações no prontuário do paciente, permitindo o acompanhamento longitudinal.

A aplicação adequada das escalas requer treinamento dos profissionais e padronização dos procedimentos. É importante considerar que outras condições, como *delirium* ou ansiedade, podem influenciar os resultados, exigindo uma interpretação contextualizada.

Imagem: Designed by Magnific



Dicas de ouro para o profissional da APS



Observe atentamente o comportamento e as reações do paciente durante procedimentos, movimentações e manipulação corporal;

Sempre que possível, utilize recursos visuais claros e validados;

Garanta a comunicação acessível e adequada, respeitando as preferências do paciente, principalmente no caso de pessoas surdas;

Consulte familiares ou cuidadores para identificar alterações no padrão de comportamento ou sinais incomuns.

Lembre-se:
a avaliação da dor deve ser contínua. Mudanças ao longo do tempo podem indicar melhora ou piora do quadro.

Conclusões e Recomendações



Importância Clínica

A avaliação sistematizada da dor em pessoas com comunicação verbal comprometida é fundamental para garantir um cuidado de qualidade e centrado no paciente, melhorando sua qualidade de vida.

Implementação

Recomenda-se a adoção das escalas PAINAD e FLACC na prática clínica, com treinamento adequado dos profissionais e estabelecimento de protocolos institucionais.

Monitoramento

A avaliação da dor deve ser realizada de forma contínua, permitindo monitorar a resposta ao tratamento e ajustar as intervenções conforme necessário.

O uso de escalas comportamentais como PAINAD e FLACC permite identificar a presença de dor, avaliar sua intensidade e monitorar a resposta ao tratamento em populações vulneráveis que não conseguem se expressar verbalmente.

A implementação dessas ferramentas na prática clínica representa um avanço significativo no cuidado humanizado e baseado em evidências, promovendo o alívio do sofrimento e a dignidade dos pacientes.



Para finalizar

Em síntese, a avaliação da dor em pessoas com comunicação verbal limitada é um ato de cuidado, respeito e compromisso com o bem-estar do paciente. Ao utilizar as ferramentas e as estratégias adequadas, podemos "ouvir" a dor que não é dita e proporcionar alívio efetivo, transformando vidas e construindo um sistema de saúde mais humano e acolhedor.



Referências

HERR, K. *et al.* Pain assessment in the patient unable to self-report: position statement with clinical practice recommendations. **Pain Management Nursing**, v. 12, n. 4, p. 230-250, 2011.

MALVIYA, S. *et al.* The revised FLACC observational pain tool: improved reliability and validity for pain assessment in children with cognitive impairment. **Pediatric Anesthesia**, v. 16, n. 3, p. 258-265, 2006.

MERKEL, S. I. *et al.* The FLACC: a behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. **Pediatric Nursing**, Pitman, v. 23, n. 3, p. 293-297, maio/jun. 1997.

WARDEN, V.; HURLEY, A. C.; VOLICER, L. Development and psychometric evaluation of the Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) scale. **Journal of the American Medical Directors Association**, v. 4, n. 1, p. 9-15, 2003.

Ficha técnica

CRÉDITOS DO CURSO

Coordenação Geral

Paulo Roberto Sousa Rocha
Julieta Carricone Fripp

Apoio Administrativo / Secretaria

Luciano Avila dos Santos

Coordenação de Conteúdo

Amirah Adnan Salman
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Consultoria e Revisão de Conteúdos

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Julieta Carricone Fripp
Manuela Samir Maciel Salman
Nathalia Oliveira da Silva
Paulo Roberto Sousa Rocha

Coordenação Pedagógica

Amirah Adnan Salman
Andrea Cristina Lovato Ribeiro
Bárbara Cury Soubhia
Manuela Samir Maciel Salman

Coordenação de Pesquisa e Relatórios

Luiz Augusto Facchini
Elaine Thumé
Elaine Tomasi

Coordenação de Mídias e Comunicação

Samir Salman
João Rocha Rodrigues
Luana Copini Jahn

Coordenação de Tecnologia e Informação

Alessander Osório

Coordenação da Produção

Alexandre Moretto Ribeiro
Andrea Cristina Lovato Ribeiro

Revisão Gramatical/Ortográfica e ABNT

Giulia M. Delazzeri

Produção Audiovisual

Eduardo Dias Abreu

Assistente de Produção Audiovisual

Luciana Melo

Animação

Márlon Lima

Ilustração

Mario Vitor Gouveia Cau

Diagramação e Design Gráfico

Daniele Rossi

Design Web e Programação

Vando Pinto

Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira
Antonio Seixlack
Arthur Fernandes da Silva
Bernardo Diniz Coutinho
Débora Silva Teixeira
Fabianna Resende de Jesus
Moraleida
Fernanda de Figueiredo Torres
Fernanda Martins Pereira
Hildebrandt
Fernanda Pereira de Paula Freitas
Francinete Araujo
Josimari Melo de Santana
Juliana Marques Coelho Bastos
Marco Túlio Cária Guimarães Pereira
Marcos Lisboa Neves
Marcos Paulo Veloso Correia
Mariana Cabral Schweitzer
Milene Zanoni da Silva
Rodrigo Macedo Pacheco
Rui Ferreira Afonso
Sandra Fortes

CRÉDITOS DESTE RECURSO DIDÁTICO

Conteúdo

Anamaria Siriani de Oliveira